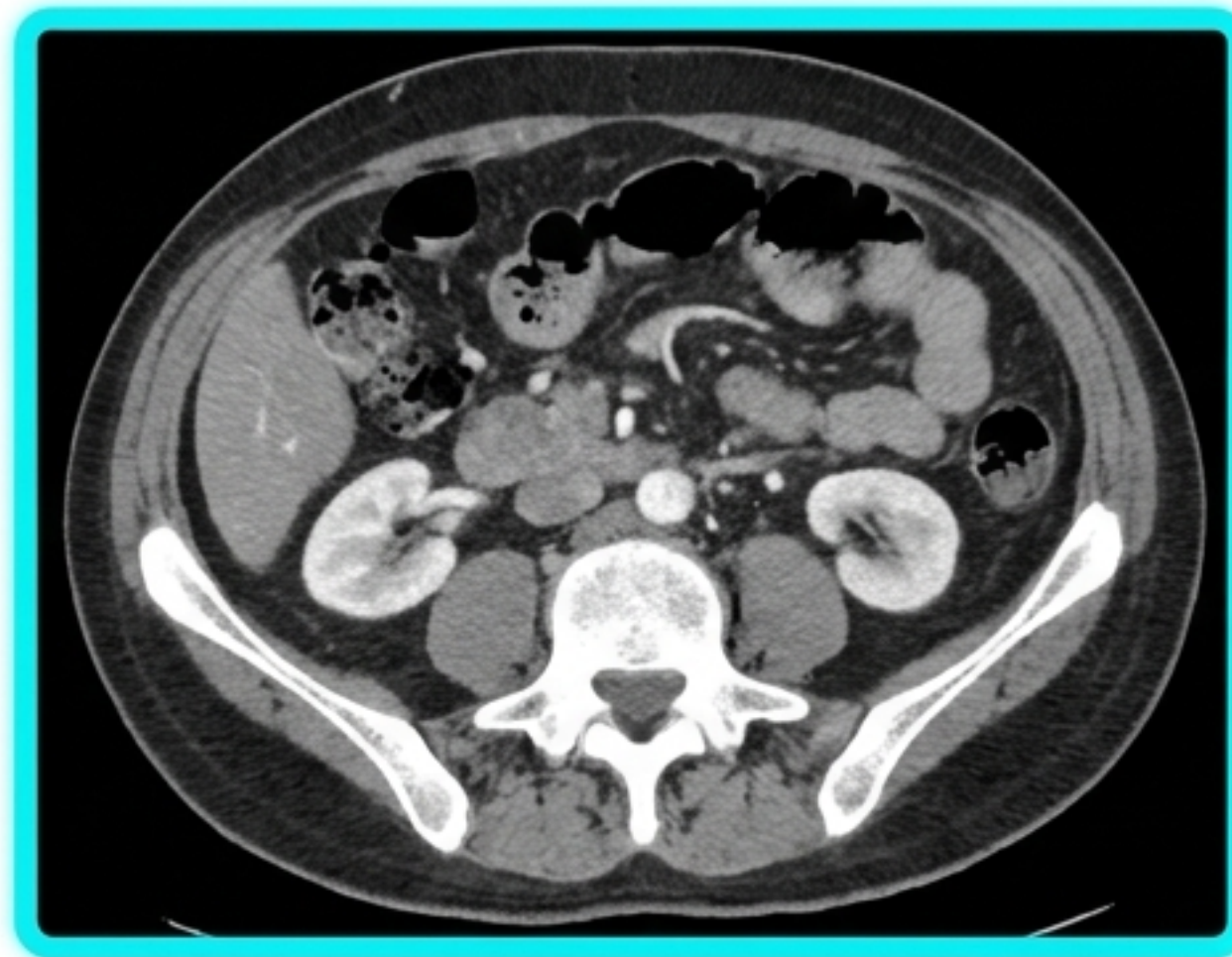


Repaso Intensivo de Cirugía General y Patología Digestiva



Guía de estudio detallada y estructurada - Proyecto BADBEAR.MED

Master Clinical Whiteboard

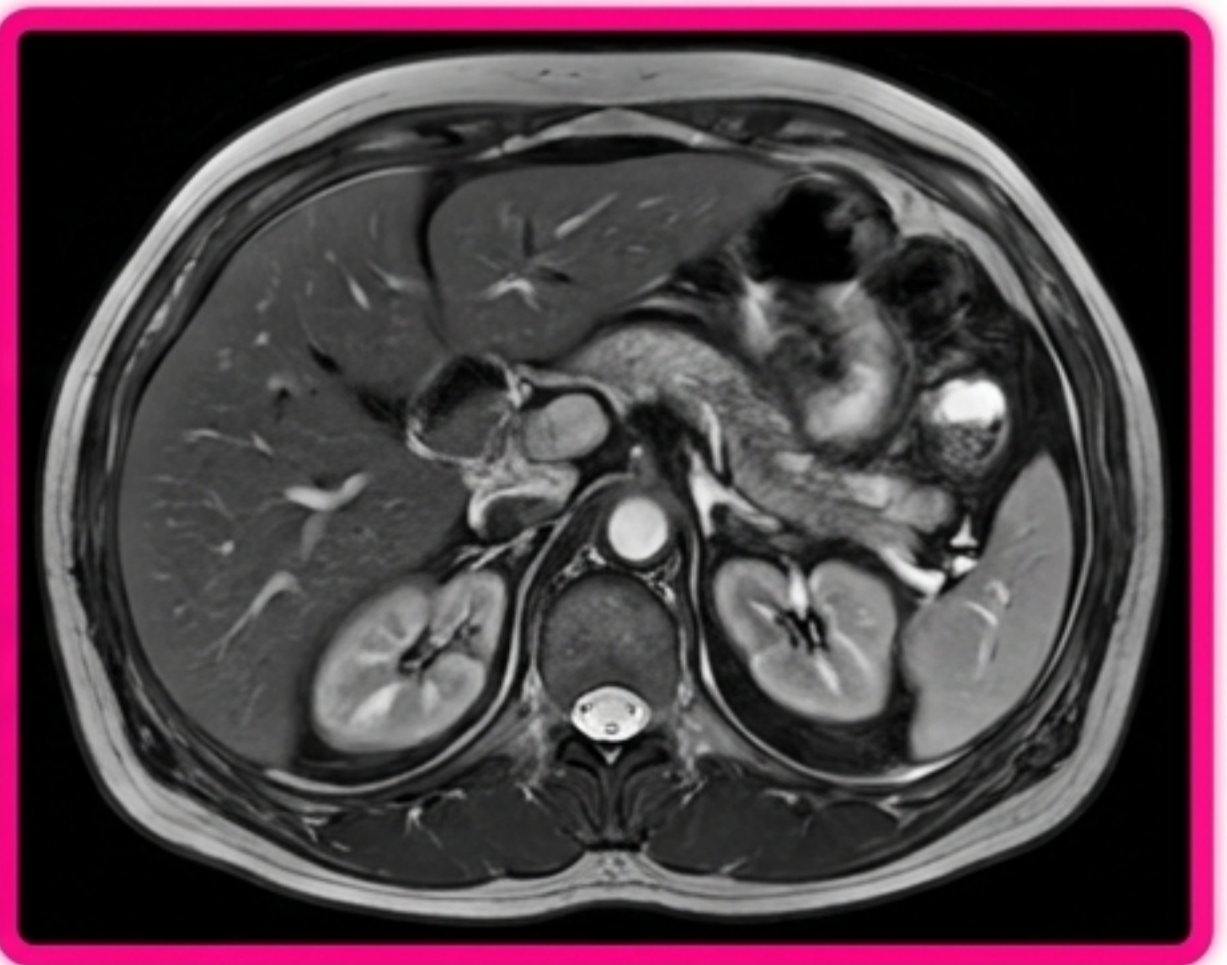


TC - Tomografía Computarizada

Utiliza Rayos X (radiación ionizante).

Fortaleza: Rapidez, evalúa inflamación, perforación, obstrucción, hemorragia y tumores.

Contraste habitual: Yodado.



MRI - Resonancia Magnética

Utiliza campo magnético y radiofrecuencia (sin radiación). **Fortaleza:** Excelente diferenciación de tejidos blandos y conductos.

Contraste habitual: Gadolinio.

BADBEAR.MED FIJA

El contraste es una herramienta adicional, no lo que define al estudio. Una imagen “con contraste” no es automáticamente mejor: **¡elige el protocolo según la pregunta clínica!**

Patología Gástrica: Clasificación de Bezoares

Fitobezoar:



Fibras y restos vegetales.

Tricobezoar:



Cabello o pelo.

Farmacobezoar:



Medicamentos acumulados.

Lactobezoar:



Componentes de la leche
(principalmente en lactantes).

Su formación es favorecida por alteraciones del vaciamiento gástrico y cambios anatómicos posquirúrgicos.

Master Clinical Whiteboard

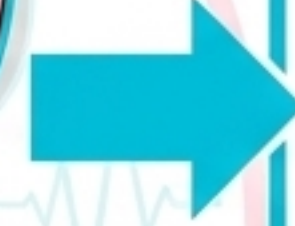
Etiología y Clínica:



Asociado a tricofagia y tricotilomanía.

El cabello resiste la digestión y se entrelaza.

Produce dolor epigástrico, saciedad precoz, vómitos y masa palpable.



Tratamiento:



Extracción Quirúrgica

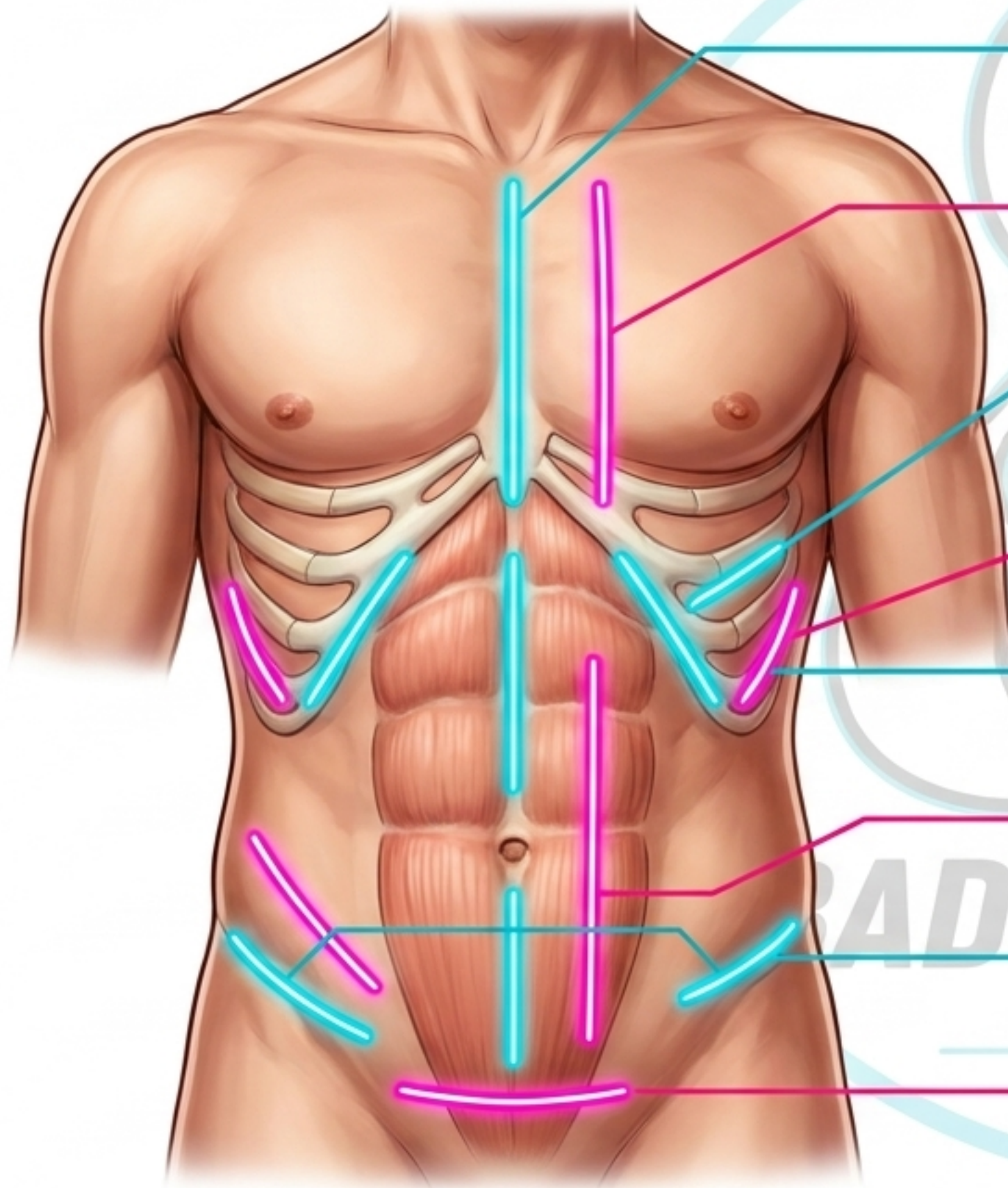


Síndrome de Rapunzel:
Tricobezoar gástrico con prolongación hacia el intestino.

BADBEAR.MED FIJA

Masa grande = Extracción quirúrgica mediante **GASTROTOMÍA** (abrir la pared del estómago, no resecarlo). No confundir con gastrectomía. Los métodos de disolución no sirven para el cabello.

Mapa Anatómico: Incisiones en Laparotomía



Mediana: Vertical por línea alba (trauma, peritonitis).

Paramediana: Vertical, lateral a la línea media.

Kocher: Subcostal derecha (biliar).

Chevron: Subcostal bilateral (exposición superior amplia).

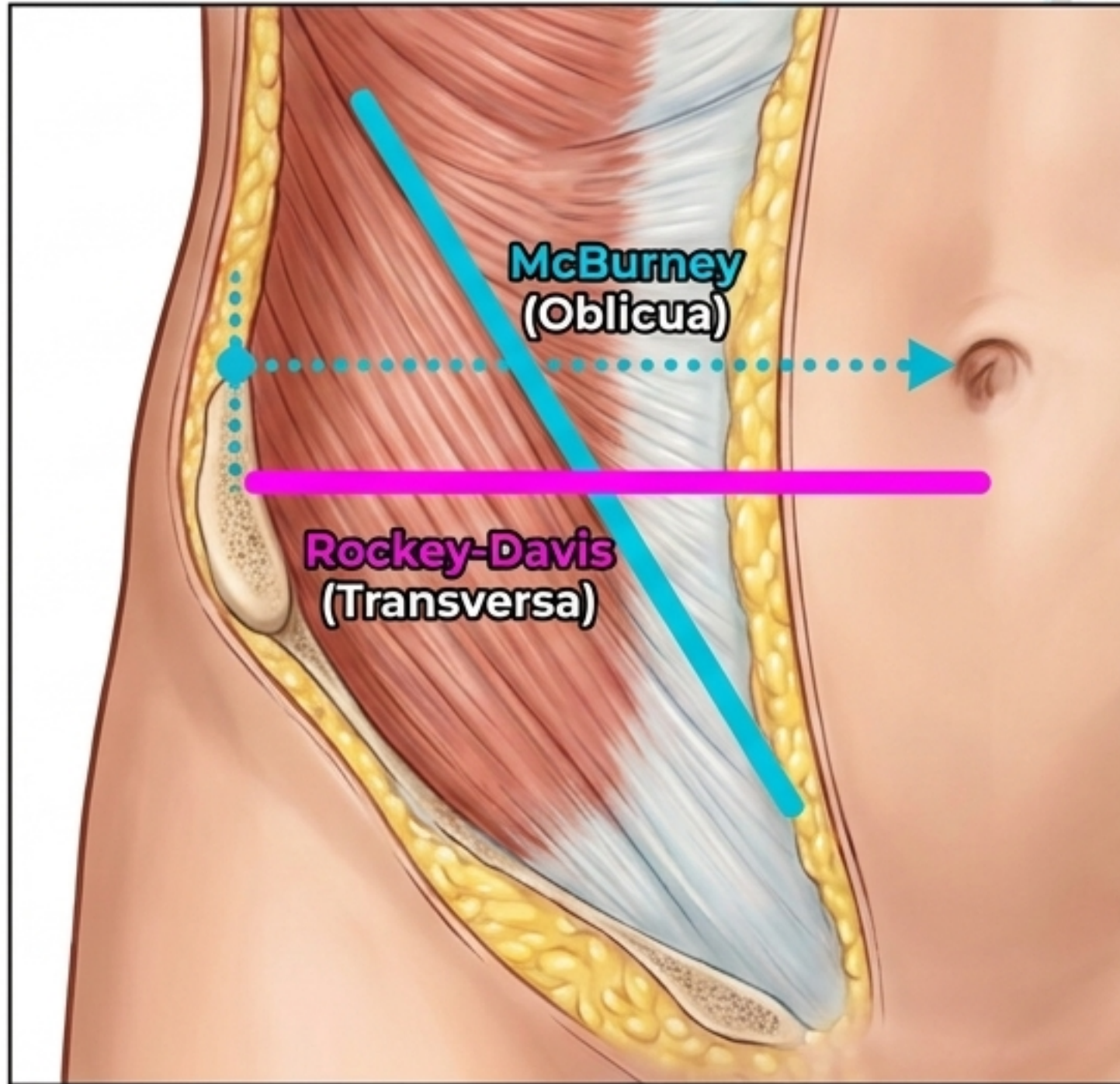
Mercedes-Benz: Chevron + extensión vertical superior (trasplante/hepática).

McBurney: Oblicua en fosa ilíaca derecha.

Rockey-Davis: Transversa en fosa ilíaca derecha.

Pfannenstiel: Transversa baja, suprapúbica (pélvica/ginecológica).

Zoom Quirúrgico: **Rockey-Davis vs. McBurney**



Anatomía del Punto:

Se ubica en la unión del **tercio lateral** con los dos tercios mediales de la **esпина ilíaca anterosuperior** al **ombligo**.

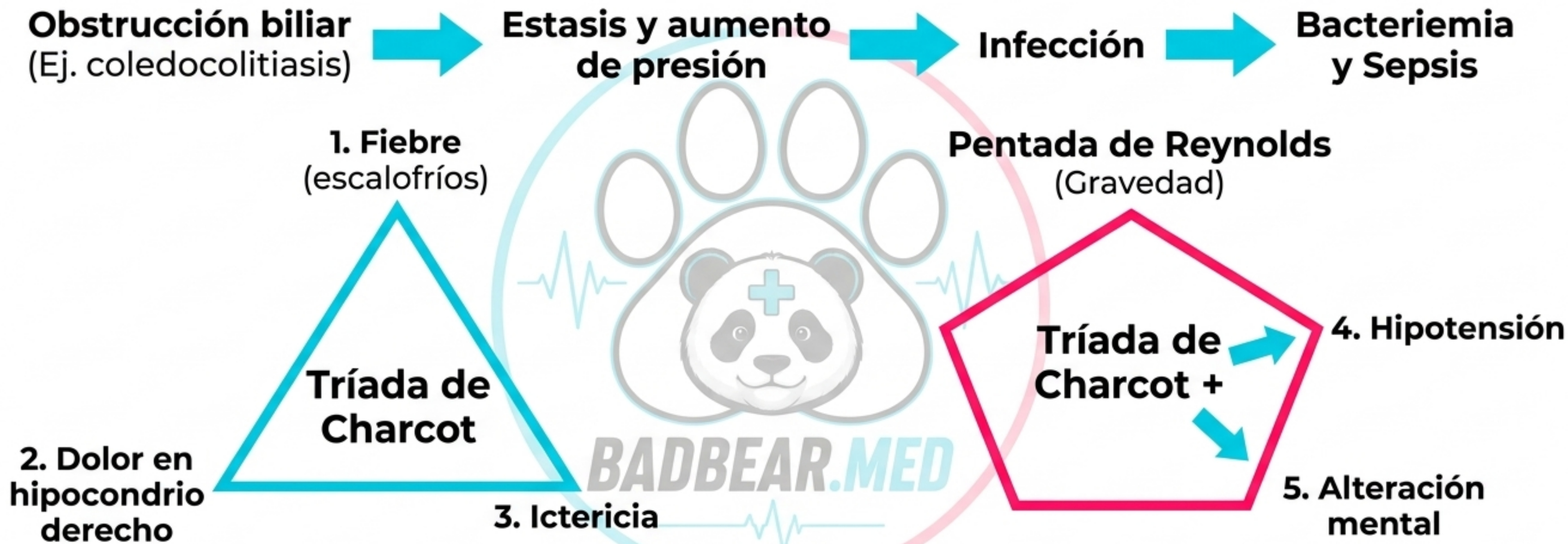
BADBEAR.MED FIJA

Rockey-Davis = TRANSVERSAL.

McBurney = OBLICUA.

¡Que la piel se incida transversalmente no significa que los planos musculares profundos se corten igual!

Fisiopatología: Colangitis Aguda



BADBEAR.MED FIJA

La presencia de la Tríada orienta fuertemente a colangitis, pero **SU AUSENCIA NO LA DESCARTA**. No esperes los 3 componentes para tratar.

Diagnóstico TG18 (Criterios de Tokio)

A. Inflamación Sistémica:

Fiebre/escalofríos o leucocitosis.

B. Colestasis:

Ictericia o alteración de pruebas hepáticas.

C. Imagen:

Dilatación biliar o evidencia de causa (cálculo/estenosis).

Gravedad en Colangitis (TG18)

Grado I (Leve):

No cumple criterios II ni III.

Grado II (Moderada):

≥2 factores (Ej. leucocitos >12k o <4k, fiebre ≥39°C, edad ≥75, bilirrubina ≥5, albúmina <70%).

Grado III (Grave):

Disfunción de al menos un órgano o sistema (cardiovascular, renal, respiratorio, neurológico, etc.).

Regla: Sospecha = A + (B o C).
Definitivo = A + B + C.

BADBEAR.MED FIJA

Los antibióticos tratan la infección, pero es indispensable DRENAR la vía biliar temprano.

Algoritmo de Decisión: **Imagen en Patología Biliar**

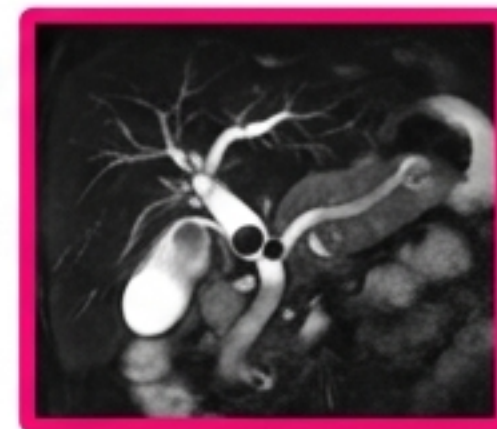
¿Dilatación inicial o cálculos vesiculares?

ECOGRAFÍA (sin contraste, rápida, inicial).



¿Cálculos en el colédoco (paciente estable)?

CPRM (Colangiorresonancia en T2, bilis brillante/cálculo oscuro, SIN contraste IV) o **Ecoendoscopia**.



¿Tumor, absceso o complicaciones?

TC CON CONTRASTE (evalúa tejidos adyacentes; ojo: puede no ver cálculos de igual densidad que la bilis).

¿Drenar y extraer el cálculo en colangitis?

CPRE (Procedimiento terapéutico, no retrasar por estudios innecesarios).

Patología Apendicular: Fases y Clasificación



1. Catarral / Congestiva

Inflamación inicial, predominantemente mucosa, congestión.



2. Supurativa / Flemonosa

Infiltración neutrofílica, exudado purulento en pared.



3. Gangrenosa

Isquemia y necrosis de la pared.



4. Perforada

Pérdida de integridad, contaminación (absceso localizado o peritonitis).

Nota: Plastrón apendicular = conglomerado inflamatorio (apéndice + epiplón), no es sinónimo de absceso.

BADBEAR.MED FIJA

En clínica, domina la distinción No Complicada vs. Complicada.
¡Las guías de Tokio NO sirven para clasificar la apendicitis!

Ergonomía Quirúrgica: Apendicectomía Laparoscópica

Americana



Americana: Paciente supino, piernas juntas. Cirujano a la izquierda, trabajando desde el lado contrario.

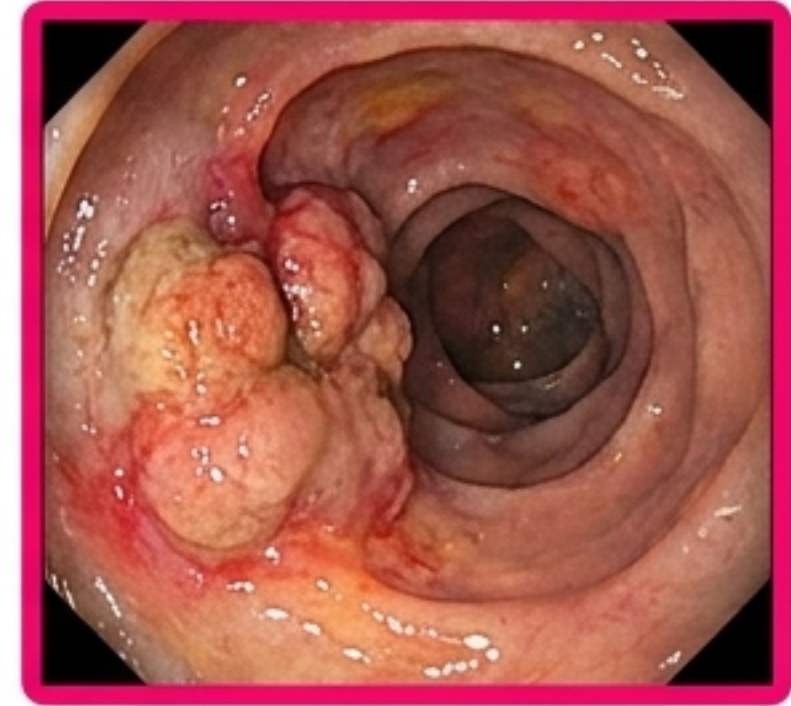
Francesa



Francesa: Paciente supino, piernas separadas. Cirujano entre las piernas, posición central.

Detalles Técnicos: Se usa cámara umbilical + 2 puertos de trabajo (ej. suprapúbico y cuadrante inferior izquierdo). Mesa en Trendelenburg con lado derecho elevado para desplazar asas intestinales. Neumoperitoneo mediante aguja de Veress (cerrado) o Hasson (abierto).

Oncología Digestiva: **Cáncer de Colon y Carnes Procesadas**



Contexto Clínico: Las nitrosaminas dañan el ADN tras activación metabólica. El aumento del cáncer de colon es multifactorial (dieta, obesidad, microbioma, genética). Los **nitratos vegetales** no tienen el mismo riesgo gracias a la **vitamina C** y **fibra**.

BADBEAR.MED FIJA

Clasificación IARC Grupo 1 para carnes procesadas: Significa **CERTEZA** de evidencia científica, **NO** que la magnitud del riesgo sea igual a fumar tabaco.

SÍNTESIS: **BADBEAR.MED** Fijas de Examen

TC vs RM:

TC = Rayos X /
RM = Campo magnético.
El contraste es opcional.

Tricobezoar:

Masa grande = Gastrotomía
(abrir, no resecar).

Incisiones F.I.D.:

Rockey-Davis = Transversal.
McBurney = Oblicua.

Posición Laparoscópica:

Americana/Francesa =
Posición del cirujano y
piernas, no cómo se corta.

Tríada de Charcot:

Fiebre + Dolor HD + Ictericia.
(Su ausencia no descarta
colangitis).

Criterios de Tokio (TG18):

A (Inflamación) + B
(Colestasis) + C (Imagen).
Grados I, II, III.

Imagen Biliar:

Ecografía inicial.
CPRM (T2) para colédoco.
CPRE para drenar.

Apendicitis:

No se clasifica con Tokio.
El enfoque es No
Complicada vs. Complicada.

Cáncer de Colon:

Carnes procesadas =
Formación de Nitrosaminas
(Compuestos N-nitroso).

¡Éxito en tu estudio y en tus exámenes!



Sigue aprendiendo con el Proyecto BADBEAR.MED.



Encuéntranos en: Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok